

TURP — Transurethral Resection ng Prostate

Impormasyon para sa Pasyente · Ang pinakakilalang operasyon para sa pinalaking prostate

WARWIKI

Ang TURP ay isang karaniwang, napatunayang operasyon para sa pinalaking prostate (BPH) na humahadlang sa daloy ng ihi. Sa pamamagitan ng scope na ipinapasok sa urethra — **walang hiwa sa labas** — tinatanggal ng siruhano ang panloob na tisyu ng prostate na pumipigil sa daanan ng ihi. Nagbibigay ito ng matibay at pangmatagalang pagbuti ng daloy at may malalim na track record sa loob ng maraming dekada.

Tungkol sa Prosedurang Ito

Isang manipis na instrumento (ang **resectoscope**) ang ipinapasok sa urethra. Gamit ang maliit na electrical loop, tinatanggal ng siruhano ang nakaharang na panloob na tisyu ng prostate nang pira-piraso, pinalalawak ang daanan ng ihi. Ang panlabas na bahagi ng prostate ay nananatili sa lugar. Inilalagay ang catheter pagkatapos habang gumagaling ang lugar.

Ligtas Ba Ito?

Ang TURP ay isa sa pinaka-pinag-aralan na urologic na operasyon at napaka-epektibo nito. Tulad ng anumang operasyon, may mga panganib — pagdurugo, impeksiyon, pansamantalang iritasyon — at ilang pangmatagalang pagbabago na inaasahan (tingnan sa ibaba). Pinaka-angkop ito para sa **katamtamang laki** ng prostate; ang napakalalaking gland ay maaaring mas angkop sa HoLEP, Aquablation, o simple prostatectomy.

MGA TERMINO

TURP

Transurethral resection ng prostate — scope surgery para sa BPH.

BPH

Benign (hindi cancer) na paglaki ng prostate.

Resectoscope

Ang scope-at-loop na instrumento na ginagamit upang tanggalin ang bahagi ng prostate.

Retrograde ejaculation

Ang tamod ay pumupunta pabalik sa pantog — karaniwang, walang mapanganib na epekto.

Catheter

Isang tubo na nagpapalabas ng ihi mula sa pantog sa loob ng 1–3 araw pagkatapos.

Bladder irrigation

Maingat na paghuhugas sa pamamagitan ng catheter upang linisin ang dugo sa unang bahagi.

ANO ANG MAGBABAGO PAGKATAPOS? Karamihan sa mga lalaki ay nakakakuha ng mas malakas na daloy ng ihi. Ang pinakakaraniwang pangmatagalang pagbabago ay **retrograde ejaculation** — ang tamod ay pumupunta pabalik sa pantog, kaya normal ang pakiramdam ng orgasmo ngunit may kaunti o walang lumalabas na likido. Ito ay walang mapanganib (bagaman nakakaapekto sa fertility). Ang malubhang epekto sa ereksyon o kontrol ng ihi ay bihira.

Paano Maghanda

- Isinasagawa sa ilalim ng **spinal o general anesthesia** — sundin ang mga tagubilin tungkol sa pag-aayuno at gamot (ihinto ang blood thinners ayon sa utos ng doktor).
- Isang **pagsusuri sa ihi** upang matiyak na walang impeksiyon bago ang operasyon.
- Maghanap ng maisasabay na taong makakauwi sa inyo; maghanda para sa catheter sa loob ng ilang araw.

Ano ang Nangyayari & Pagkatapos

- 1 Kayo ay natutulog o namamanhid; ibinibigay ang antibiotics.
- 2 Ang nakaharang na tisyu ng prostate ay tinatanggal sa pamamagitan ng scope.
- 3 Inilalagay ang catheter, kung minsan may maingat na bladder rinsing sa unang araw.
- 4 Kadalasan isang gabi sa ospital; tinatanggal ang catheter sa loob ng **1–3 araw**.

Asahan ang **ihing may halong dugo** at ilang pakiramdam ng pangangati o urgency sa loob ng ilang linggo; uminom ng maraming tubig at iwasan ang pag-igting at mabigat na pagbubuhat.

Tawagan ang inyong care team kung kayo ay may:

- **Hindi kayo makaihi** pagkatapos matanggal ang catheter
- **Malakas na pagdurugo o mga namuong dugo** na humahadlang sa daloy
- Lagnat o panginginig
- Pagdurugo na lumalala (ang kaunting pagdurugo sa ika-1–2 na linggo ay karaniwan — magpahinga at uminom ng maraming tubig)

TATLONG BAGAY NA DAPAT TANDAAN

1. Tinatanggal ng TURP ang nakaharang na panloob na prostate sa pamamagitan ng scope (walang hiwa) — ang matagal nang pamantayan at napaka-epektibong lunas para sa katamtamang BPH.
2. Asahan ang mas malakas na daloy; ang karaniwang pangmatagalang pagbabago ay dry/retrograde ejaculation (walang mapanganib).
3. Ang ihi na may halong dugo at iritasyon ay nawawala sa loob ng ilang linggo. Tumawag kung hindi makaihi, malakas na pagdurugo, o lagnat.